

Cuidar a personas autistas de cualquier edad en su clínica

La guía acumulativa para los médicos de familia y los profesionales de la salud — a lo largo de todo el ciclo de vida autístico, desde la etapa preescolar hasta la vejez en apoyo intensivo. Una ficha de referencia extendida; a coupler con las guías rápidas por edad.

la idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos. Dentro de un túnel, la focalización es vívida; fuera de él, las cosas apenas se registran — incluyendo a veces la dolor o que alguien hable—; y cambiar de túnel cuesta una energía real. Esta diferencia única explica las reacciones sensoriales, los intereses fuertes, la necesidad de rutina y los meltdowns/shutdowns que traen a las personas autistas a su consulta. **Trabaje con el túnel, no contra él.** La clínica es uno de los entornos más difíciles para una persona monotrópica — pequeños ajustes predecibles cambian los resultados.

Lo que ayuda a cualquier edad

- **Envíe un formulario de ajustes previos a la visita** (la herramienta *Autism Healthcare Accommodations Tool* de AASPIRE, autismandhealth.org) y léalo antes de que lleguen.
- **Reduzca la carga sensorial:** luz tenue, sala más tranquila, menos pitidos, sin perfumes fuertes; ofrezca la primera o la última cita (las más tranquilas).
- **Comunique de forma literal y por escrito:** explique cada paso *antes* de realizarlo; diga exactamente lo que quiere decir; ofrezca un resumen escrito y un seguimiento escrito o en línea; deje largos silencios para el procesamiento.
- **Permita un acompañante de confianza y un kit sensorial** (auriculares, gafas de sol, objeto de manipulación/interés); deje que la persona desvíe la mirada, haga stimming o use CAA.
- **Co-crea una rutina de cuidados predecible:** misma sala, misma secuencia, ajustes efectivos guardados en el historial para que sean automáticos la próxima vez.
- **Trate a la persona como la experta en su propia experiencia** — el autoinforme es la prueba primaria.

Lo que hay que evitar a cualquier edad

- Forzar el contacto visual, realizar procedimientos sorpresa, utilizar la contención o usar frases como «¡sé valiente!».
- Interpretar unos pocos minutos de calma y camuflaje como que «están bien», o un bloqueo (*shutdown*) como un rechazo a colaborar.
- Assimilar el hecho de «no quejarse» con «no sufrir» (las diferencias de intéroception significan que la dolor y los síntomas pueden retrasarse o ser atípicos).

Preescolar (2-5 años)

Atención «pegajosa» y lenta, intereses focalizados intensos, diferencias sensoriales y juego atípico son signos tempranos — **derive temprano** para una evaluación. Únase al interés del niño antes de examinarlo; acepte un objeto de confort. Tome en serio la preocupación parental.

Escuela primaria (6-11 años)

El patrón clásico del camuflaje: «está bien en la escuela, colapso en el hogar/clínica». Pregunte sobre la **carga escolar y la recuperación**, no solo sobre los síntomas. Vigile el burnout/«regresión» bajo sobrecarga — reduzca las demandas, no presione. Dépiste las co-ocurrencias comunes (ansiedad, TDAH/AuDHD, sueño, GI).

Adolescencia (12-18 años)

La **edad crítica para la ansiedad, la depresión y el burnout**; muchos son identificados por primera vez en situación de crisis. **Dépiste la suicidalidad directamente**. Distinga el burnout autístico (requiere reducción de demandas + desmasquar) de la depresión. Valide los intereses como parte de la identidad y la recuperación. Planifique temprano la transición a los servicios para adultos.

Universidad / estudios sup. (18-25 años)

Una transición masiva; muchos chocan contra un muro en el 1.er o 2.º año. Ofrezca opciones **priorizando lo escrito**. Reconozca el burnout frente al estrés estudiantil ordinario. Una reducción temporal de la carga académica es un paso de recuperación legítimo, no un fracaso.

Adulto activo

En el entorno adecuado: fortalezas profundas. En el incorrecto: agotamiento crónico, camuflaje, **burnout** (distinto del burnout laboral y la depresión). Pregunte sobre la carga laboral; **comience los medicamentos a dosis bajas y titule lentamente** (las respuestas atípicas son comunes). Oriente hacia los ajustes en el lugar de trabajo.

Padre

La paternidad es implacablemente multi-canal — alto riesgo de **burnout**, y a menudo ignoran su propia salud (intéroception + hiperfocalización en el niño). Haga que los cuidados perinatales sean predecibles y tranquilos; depiste proactivamente las necesidades del padre; tienden a sub-declarar.

Adulto mayor (60+)

El grupo menos investigado y con peores resultados; muchos nunca fueron identificados. Vigile décadas de burnout acumulado, a menudo malinterpretado como «envejecimiento». **Distinga cuidadosamente la diferencia autística de la demencia** — la evidencia es escasa; evalúe, no suponga. Proteja los intereses y rutinas de toda la vida; tenga en cuenta la pérdida de audición o visión que se suma a las diferencias sensoriales.

Apoyo intensivo / residencial (cualquier edad)

Trate cualquier nueva angustia como **dolor o sobrecarga hasta que se demuestre lo contrario** (la constipación, el dolor dental, la infección, un equipo mal ajustado son causas ocultas comunes). Utilice la toma de decisiones asistida; preserve las rutinas, los objetos y los intereses; tenga un plan tranquilo para el meltdown/shutdown (reducir la estimulación, asegurar la seguridad, no contener).

Señales de alarma transversales

El burnout autístico no es depresión — agotamiento crónico, pérdida de habilidades y reducción de la tolerancia a los estímulos; tratarlo como depresión o decir «haz un esfuerzo» lo agrava y aumenta el riesgo de suicidio. **El camuflaje en la clínica es costoso** — no deje que 15 minutos de compostura anulen el historial. **«No quejarse» ≠ «no sufrir»** — pregunte proactivamente sobre el dolor y los síntomas. **Una nueva angustia en una persona en apoyo intensivo es una señal de alarma médica** hasta que el dolor y la sobrecarga sean excluidos. Centrese siempre en el individuo; una minoría de personas autistas no se identifican con el monotropismo.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 2–5) y la brève sobre el **Monotropismo**. Utiliza el lenguaje de identidad primero («persona autista»). **Informativo — no es un consejo médico ni una herramienta de diagnóstico**. El monotropismo es una teoría poderosa pero aún en desarrollo; la evidencia sobre la vejez y el apoyo intensivo es escasa — sea honesto sobre la incertidumbre y adapte al individuo.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2018/2023); Dwyer (2021, 2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Mantzalas et al. (2022); Pearson & Rose (2021, masking); Kelly Mahler (2024, interoception); Klein et al. (2024, aging); AASPIRE Healthcare Toolkit / AHAT; Autism Society (2025, meltdowns/shutdowns). Las citas completas están en los borradores fuente.